

CrownOps_중간발표_대본_2026-05-27

개인 페이지 & 공유된 페이지/자료실/문서허브-2/중간발표/CrownOps_중간발표_대본_2026-05-27

36b0b56c63ab811d90c7ec99b5e85495.md

원본 형식: md

CrownOps_중간발표_대본_2026-05-27

안녕하십니까. CrownOps 팀 발표를 맡은 이견영입니다.

저희 팀은 6월 15일 최종 발표를 목표로, 치기공소의 AX 전환 아이디어를 계속 검증하고 있습니다. 오늘은 최종 결론을 내리는 자리가 아니라, 지난 2주 동안 저희가 어떤 가설을 가지고 움직였고, 어떤 인터뷰를 통해 문제정의가 어떻게 더 구체화되었는지 말씀드리겠습니다.

저희가 처음 잡은 문제는 치기공소에서 발생하는 휴먼 에러였습니다. 치과에서 온 스캔 파일과 실제 케이스가 잘못 매칭되거나, 수정 전 파일과 수정 후 파일이 함께 들어가거나, 디스크 두께나 재료, 웨이드 선택이 잘못되거나, 밀링해야 할 케이스가 누락되는 식의 문제입니다. 이런 문제는 한 번 발생하면 재료비와 작업 시간이 낭비되고, 경우에 따라 재제작과 납기 지연으로 이어집니다.

다만 이번 검증을 통해 알게 된 점은, 이 문제가 모든 현장에서 똑같이 절박하게 인식되는 문제는 아니라는 것입니다. 어떤 기공소에서는 이미 어느 정도 감수하고 가는 비용이고, 어떤 치과에서는 5%에서 10% 미만의 리메이크는 현실적으로 발생할 수 있다고 보고 있었습니다. 그래서 저희는 이 문제를 이미 모두가 강하게 인식하고 있는 발생형 문제라기보다, 손실을 데이터로 보여주고 줄일 수 있을 때 가치가 생기는 탐색형 문제로 보고 있습니다.

지난 2주 동안 저희는 크게 세 가지를 진행했습니다. 첫 번째는 데스크 리서치입니다. 국내 치기공소 시장, 해외 진출 가능성이 있는 일본, 영국, 독일 시장, 그리고 치기공소 운영 보조 소프트웨어가 법적으로 어디까지 가능할지 조사했습니다. 조사 결과, 저희가 직접 보철물을 제작하는 방향이 아니라 등록된 치기공소 내부에서 쓰이는 운영 보조 소프트웨어로 들어가야 한다는 경계를 다시 확인했습니다.

두 번째는 현장 언어를 익히는 작업이었습니다. 지르코니아 디스크, 티수, 웨이드, 교합, 마진, 피니싱 라인, 알지네이트 인상 같은 용어를 정리하면서, 다음 인터뷰에서 현장 분들의 말을 더 정확히 이해하려고 했습니다.

세 번째는 인터뷰입니다. 이번에는 세 방향에서 들었습니다. 먼저 강릉이닷컴이라는 소규모 치기공소 소장님과 전화 인터뷰를 했습니다. 이곳은 현재 두 명이 운영하는 작은 기공소라서, 저희가 생각한 휴먼 에러가 지금 당장은 많이 발생하지 않는다고 했습니다. 이유는 단순했습니다. 사람이 적으면 전달 과정이 짧고, 그래서 사람 사이에서 생기는 실수도 줄어든다는 것입니다. 다만 과거에 더 많은 인원으로 운영했을 때는 직원 한 명의 실수가 거래처 이탈로 이어진 경험도 있었다고 말씀해주셨습니다. 이 인터뷰를 통해 저희는 초기 타깃이 아주 작은 기공소보다는 사람이 늘고, 파일과 장비와 케이스가 동시에 움직이는 기공소일 가능성이 높다고 판단했습니다.

두 번째로는 마이엠치과 원장님을 인터뷰했습니다. 여기서 확인한 것은 치과 입장에서 리메이크가 단순히 기공소만의 비용이 아니라는 점입니다. 보철물이 맞지 않으면 치과는 환자에게 비용을 다시 청구하기 어렵고, 스캔이나 인상을 다시 떼야 하며, 환자에게 양해를 구해야 합니다. 원장님은 본인 병원 기준으로 리메이크 비용이 5%에서 10% 미만이라고 말씀하셨고, 10% 정도까지는 어느 정도 현실적인 오차로 보는 분위기도 있다고 했습니다. 또 아직도 디지털 스캔만이 아니라 알지네이트 인상을 쓰는 치과가 있다는 점도 확인했습니다. 그래서 저희는 초기 MVP는 디지털 파일 흐름부터 보되, 이후에는 아날로그 의뢰 정보까지 어떻게 연결할지

고민해야 한다고 보았습니다.

세 번째로는 가천대 길병원 보철과 교수님께 질문지를 드리고 피드백을 받았습니다. 여기서 가장 중요했던 점은 보철물 리메이크가 기공소 내부 제작 오류만의 문제가 아니라는 것입니다. 치과에서 기공소로 넘어가는 스캔 파일, 웨이드, 교합, 임플란트 정보가 정확히 연결되지 않으면 기공소가 아무리 잘 만들어도 오류가 생길 수 있습니다. 또 보철물이 늦어지거나 다시 제작되면 치과에서는 체어타임이 늘고, 환자 신뢰에도 영향을 줄 수 있습니다. 이 부분은 저희가 처음에는 충분히 보지 못했던 지점입니다.

그래서 현재 저희의 결론은 이렇습니다. 큰 방향성은 바꾸지 않습니다. 저희는 여전히 치기공소의 CAD, CAM, 밀링 워크플로우에서 발생하는 휴먼 에러를 줄이는 AX 전환 솔루션을 보고 있습니다. 다만 MVP의 초점은 더 좁아졌습니다. 처음부터 완전 자동화 기공소를 만들겠다는 것이 아니라, 먼저 파일의 중복과 누락, 구 버전 사용, 재료와 웨이드와 디스크 두께 선택, 작업 상태 업데이트 같은 지점을 확인하고, 이로 인한 손실을 리포트로 보여주는 것부터 시작하려고 합니다.

다음 단계는 이번 주 금요일 강릉이닷컴을 직접 방문하는 것입니다. 전화 인터뷰에서는 작은 기공소의 특성을 들었다면, 방문 때는 실제로 어떤 순서로 의뢰가 들어오고, 어디에서 실수가 생길 수 있고, 어떤 부분은 소프트웨어로 해결 가능하고 어떤 부분은 현장 습관 때문에 어려운지 확인하려고 합니다. 가능하다면 소장님뿐 아니라 실제 작업자 입장도 들어볼 예정입니다.

또 서울대학교 보철과 교수님들과도 미팅을 시도하고 있습니다. 이 미팅이 성사된다면, 저희 솔루션이 치과의사 입장에서 의미 있는지, 그리고 치과와 기공소 사이의 정보 연결 문제까지 확장할 수 있는지 검증하고 싶습니다.

최종 발표 전까지 저희가 해야 할 일은 명확합니다. 첫째, 어떤 휴먼 에러가 실제로 가장 자주 발생하는지 현장에서 확인하겠습니다. 둘째, 그 에러가 월 단위로 얼마의 손실을 만드는지 계산해보겠습니다. 셋째, 그 손실을 줄이는 MVP를 어디까지 만들 수 있을지 보여드리겠습니다. 오늘 발표는 여기까지입니다. 감사합니다.